

38 - AVORTEMENTS SPONTANÉS - Pr. AIT BENKADDOUR

(0:05 - 0:49)

Ceci est un cours sur les avortements spontanés destiné aux étudiants de 5e année des études médicales de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech dans le cadre du module de gynécologie obstétrique. C'est un cours qui revêt une importance capitale vu la fréquence de ce phénomène qui est les avortements spontanés, de son retentissement sur la vie reproductive des femmes et des couples et aussi le retentissement psychologique. L'avortement spontané est défini comme étant l'interruption spontanée de la grossesse avant la période de viabilité qui est définie actuellement entre 22 et 24 semaines.

(0:50 - 1:17)

La fréquence de ce phénomène est élevée et dépend de la méthode diagnostique. Quand on parle des avortements uniquement cliniques, ça représente 10 à 25 % de toutes les grossesses. Quand on parle des avortements précliniques, c'est-à-dire avant les signes cliniques de la grossesse, presque 50 % des fécondations ne vont pas aboutir à une naissance vivante.

(1:17 - 2:15)

Sur le plan nosologique, on distingue les avortements précoces ou avortements du premier trimestre avant 12 semaines et qui sont de loin les plus fréquents et les avortements tardifs ou les avortements de deuxième trimestre qui sont moins fréquents mais qui sont particuliers. Le phénomène de reproduction dans l'espèce humaine est un phénomène très sélectif comme le montre cette pyramide qui représente les pertes embryonnaires et fœtales depuis la conception, c'est-à-dire depuis la fécondation jusqu'à la naissance vivante. Vous voyez qu'uniquement 30 % des œufs fécondés vont aboutir à une naissance d'un nouveau-né en bonne santé et que 30 % vont s'avorter avant même les signes cliniques, c'est-à-dire après l'implantation.

(2:15 - 2:59)

30 % ne vont pas s'implanter et 10 % vont donner un avortement après le diagnostic de la grossesse. Les facteurs de risque des avortements spontanés, que ce soit les avortements pour la première fois ou à répétition, sont globalement l'âge maternel qui est un facteur capital avec un seuil de 35 % et une augmentation considérable au-delà de 40 ans. Les antécédents d'avortement, une femme qui a déjà un ou deux antécédents d'avortement a plus de risque d'avoir un troisième avortement et ceci est lié au nombre d'avortements dans les antécédents.

(2:59 - 3:47)

Les grossesses multiples sont aussi un facteur de risque, le diabète maternel, surtout s'il est mal équilibré, et les maladies de système. Sur le plan des étiologies, la première cause d'avortement

du premier trimestre est essentiellement les anomalies génétiques du conceptus de l'embryon, que ce soit les anomalies chromosomiques ou les anomalies géniques, et aussi les anomalies structurelles, les malformations majeures avec ou sans substratum génétique. Les anomalies endocriniennes viennent en deuxième lieu, les malformations utérines, les pathologies immunologiques, les infections, et dans un certain nombre de cas, on ne retrouve aucune étiologie.

(3:49 - 4:54)

Les causes génétiques peuvent être subdivisées, comme on l'a dit, en causes chromosomiques, qui sont responsables de 60% des avortements du premier trimestre et pratiquement 80% des œufs clairs, et comme vous le voyez, c'est de loin la cause la plus fréquente et qui témoigne d'un processus de sélection et qui est la conséquence le plus souvent d'anomalies au cours de la fécondation ou des premières divisions mythotiques et qui témoignent aussi le plus souvent d'un état ovocitaire de mauvaise qualité. Il existe évidemment des causes géniques, mais qui sont moins fréquentes et en tout cas plus difficiles à mettre en évidence. Les anomalies chromosomiques incluent toutes les anomalies de nombre, que ce soit les triploïdies, qui vont donner en général des molles et datiformes, les tétraploïdies, qui représentent 6%, ou les trisomies, les plus fréquentes sont les 16, les 22, les 21, les 13, les 18.

(4:54 - 5:42)

Les monosomies X, aux syndromes de Turner, peuvent aussi être une cause d'avortement précoce et il existe évidemment des anomalies chromosomiques qualitatives, comme les délétions et surtout les translocations. Deuxième chapitre, dans les étiologies des avortements spontanés du premier trimestre, sont les malformations utérines et qui sont représentées essentiellement par l'utérus cloisonné, qui est responsable des avortements dans 10 à 15% des cas. Les utérus bicornes ou plus rarement les utérus hypoplasiques, qui peuvent être mis en évidence en échographie, ou par une hystérométrie, ou à l'hystérosalpingographie.

(5:43 - 6:37)

Il existe évidemment des causes anatomiques acquises, comme les fibromes, surtout les fibromes intracavitaires, ou les synéchies. Les béances cervico-isthmiques, qui témoignent d'une insuffisance, soit fonctionnelle ou anatomique, du col utérin, sont responsables de 20%, mais plutôt des avortements du deuxième trimestre. Comme vous le voyez sur ce schéma, la différence entre l'utérus cloisonné ou un cloison utérine sur l'image à gauche et l'image de droite qui montre l'utérus bicorne et qui témoigne d'une malformation secondaire, un défaut de fusion des hémimatrices, contrairement à l'utérus cloisonné, qui est une anomalie de résorption de la cloison après la fusion.

(6:38 - 7:06)

Les anomalies acquises, comme on l'a dit, peuvent s'agir de fibromes ou de synéchies, comme on le voit sur l'image du milieu. La différence entre l'utérus cloisonné et l'utérus bicorne n'est pas toujours aisée et on se base sur plusieurs examens paracliniques. Ici, on voit l'hystérosalpingographie qui va montrer une double cavité, mais qui ne permet pas de juger si c'est un utérus cloisonné ou un utérus bicorne.

(7:06 - 7:50)

Et les examens qui vont permettre de faire la part des choses sont essentiellement l'échographie avec l'utilisation de l'échographie plutôt 3D, l'IRM, la stéréoscopie. Cependant, l'hystérosalpingographie et l'hystérocopie ne permettent pas de faire la part des choses. On voit ici une image hystérosalpingographique au milieu et qui ne permet pas de faire la part des choses, et des images échographiques, surtout avec la reconstruction 3D, qui permet de voir ici à gauche des images d'utérus cloisonné et ici à droite des images d'utérus bicorne.

(7:50 - 8:38)

L'IRM, dans les cas les plus difficiles et les plus litigieux, est d'un grand apport, et comme vous le voyez, les images sont assez claires et montrent ici à droite un utérus cloisonné et ici à gauche un utérus cloisonné et à droite un utérus bicorne. L'hystérocopie, comme vous le voyez sur cette image en haut, montre une cloison au milieu, mais qui ne permet pas de prédire l'aspect extérieur et donc ne permet pas de faire la part des choses. Contrairement à la stéioscopie, comme vous le voyez sur l'image de droite, deux hémimatrices, c'est-à-dire un utérus bicorne, et à gauche un fond utérin normal, c'est-à-dire un utérus cloisonné.

(8:41 - 9:23)

Troisième chapitre des étiologies des avortements spontanés, ce sont les causes endocriniennes. Il s'agit du diabète déséquilibré, de l'hypothyroïdie, qu'elle soit cliniquement évidente ou latente, des hyperprolactinémies et de l'insuffisance luthérale. Les causes infectieuses sont moins fréquemment responsables d'avortements précoces et peuvent être soit des causes générales, comme des infections virales à CMV, rubéole, herpès, bactériennes comme la syphilis, qui est fréquemment responsable des avortements du deuxième trimestre.

(9:23 - 9:44)

La listeriose aussi est une cause assez fréquente des avortements du deuxième trimestre, surtout en Europe. Cependant, dans notre pays, cette infection reste rare, voire exceptionnelle. Les infections à chlamydia et mycoplasme peuvent aussi être responsables d'avortements, ainsi que la toxoplasmose.

(9:44 - 10:08)

Les causes locales peuvent aussi être une des causes des avortements, surtout du deuxième trimestre. Il s'agit des infections cervicales, cervico-vaginales, voire même utérines. L'œuf, au premier trimestre, étant très sensible et peut être sensible à la fièvre, parfois n'importe quelle hyperthermie d'origine infectieuse peut entraîner un avortement.

(10:11 - 11:04)

Les causes générales d'avortements sont essentiellement les cas d'insuffisance rénale chronique, d'insuffisance hépatique chronique, les maladies de système surtout avec vascularite et l'intoxication alcool-tabagique qui augmente de manière considérable le risque d'avortement spontané, que ce soit du premier ou du deuxième trimestre. Les causes immunologiques et essentiellement le lupus et le syndrome des anticorps antiphospholipides témoignent d'un rejet du greffon fœtal avec des anticorps contre les composants du fœtus et va entraîner plutôt des avortements à répétition avec un contexte clinique souvent évocateur. Les autres causes, notamment les causes toxiques, que ce soit le tabac, l'alcool, les drogues ou même parfois les produits anesthésiques.

(11:05 - 12:45)

Les causes traumatiques, que ce soit des traumatismes domestiques ou des traumatismes iatrogènes comme la myosynthèse, la biopsie, l'utrophoblaste ou la chirurgie abdominale peuvent être des causes d'avortement. Après avoir vu de manière sommaire les différentes causes des avortements, on va passer au diagnostic et avant de parler de chaque tableau clinique d'avortement spontané, on va énumérer les tableaux cliniques puisqu'il s'agit d'une multitude de variantes sémiologiques et on parle actuellement d'une classification des tableaux cliniques des avortements, le plus fréquent étant la menace d'avortement, en deuxième les avortements en cours ou ce qu'on appelle les avortements inévitables, en troisième lieu les avortements incomplets et en quatrième lieu les avortements complets avec évacuation utérine complète et en cinquième position les grossesses arrêtées. Dans tous les cas, la prise en charge initiale, diagnostique et thérapeutique des cas d'avortement spontané doit toujours commencer par une évaluation de l'état hémodynamique puisque comme on va le voir dans certains cas, il y a un risque d'hémorragie faudroyante avec retentissement hémodynamique et si nécessaire, entamer rapidement la réanimation de la patiente avec la prise de voies veineuses périphériques, le remplissage, le bilan, voire même la transfusion.

(12:45 - 13:57)

Donc, l'examen clinique initial doit comporter évidemment un interrogatoire puis un examen gynécologique permettant d'évaluer la taille de l'utérus, l'abondance de saignements, l'ouverture du col ou toucher vaginale, la présence de douleurs et la présence de masses latéraux utérines. Donc, on va commencer par le tableau de menaces d'avortement qui est défini par la présence de métrorragie sur une grossesse évolutive de moins de 22 semaines sachant que les douleurs

pélviennes ne constituent pas un symptôme évocateur de menaces d'avortement puisque c'est un symptôme qui est assez fréquent et qui ne témoigne pas d'un risque plus élevé d'avortement du premier trimestre. Donc, devant une patiente qui vient pour un saignement au premier trimestre, ou parfois même juste des métrorragies associées à un retard des règles donc sur une grossesse existante mais qui n'est pas encore diagnostiquée, on va retrouver les signes de menaces qui sont les métrorragies plus ou moins associées aux douleurs pélviennes.

(13:58 - 14:53)

L'examen au spéculum systématique va confirmer l'origine du saignement d'origine endo-utérine et va permettre d'éliminer les causes cervicales de ces saignements et le toucher vaginal va permettre de diagnostiquer ou de retrouver un col en général fermé, long avec un utérus augmenté de volume. Le diagnostic ne peut être retenu qu'après avoir mis en évidence la présence d'une grossesse et confirmé le caractère évolutif de cette grossesse. Donc l'échographie va permettre d'apprécier la vitalité de l'embryon et de préciser aussi le terme sachant que le sac gestationnel est normalement visible à partir de 4 semaines et demie voire 5 semaines par l'échographie endovaginale et 6 semaines par la voie abdominale.

(14:54 - 15:43)

L'échographie va aussi permettre d'éliminer les diagnostics différentiels, notamment la grossesse extra-utérine qui constitue une urgence médico-chirurgicale ou la molle hidatiforme. Comme vous le voyez sur ces images l'échographie va permettre de diagnostiquer des sacs gestationnels très jeunes avec un aspect de courant trophoblastique cependant dans ces cas là on ne peut pas confirmer qu'il s'agit d'une grossesse de façon certaine jusqu'à commencer à avoir les annexes fœtales comme vous le voyez sur les images de droite et le premier annexe fœtale qui apparaît et la vésicule vitéline qui est bien visible sur ces images là. Un peu plus tard l'embryon va être visible et l'activité cardiaque va confirmer l'évolutivité de la grossesse.

(15:43 - 16:33)

Sur cette image on voit qu'à 10 semaines l'embryon est déjà visible et l'activité cardiaque doit être visible à ce terme là. Parfois il existe des signes échographiques évoquant une menace d'avortement ou renforçant la suspicion de la menace et il s'agit essentiellement des décollements trophoblastiques qu'on appelle aussi des hématomes périovulaires qui peuvent être de petit diamètre sans signification pronostique péjorative ou volumineux témoignant de la menace d'avortement. Deuxième signe de la menace d'avortement est le caractère plus petit du sac gestationnel par rapport à l'âge présumé de la grossesse.

(16:34 - 17:07)

Au deuxième trimestre, l'échographie va permettre aussi de rechercher une cause à ces menaces d'avortement de voir la localisation placentaire et aussi d'évaluer le fœtus à la

recherche de malformations. Comme vous le voyez ici sur l'image d'en haut, un aspect de décollement trophoblastique majeur qui témoigne d'une menace d'expulsion avec un grand risque d'avortement. Sur l'image d'en bas, un petit décollement avec un petit hématome sans signification pronostique péjorative.

(17:09 - 17:51)

Deuxième tableau clinique, des avortements spontanés et l'avortement en cours ou ce qu'on appelle l'avortement inévitable. Il s'agit d'une patiente qui va venir parce qu'elle a des saignements qui sont de plus en plus abandonnés, parfois très abandonnés, associés à des douleurs le plus souvent de type expulsif. Le diagnostic clinique est souvent aisé par la mise en place du spéculum qui va permettre de voir parfois le produit de conception en partie au niveau du vagin ou au niveau du col et le toucher vaginal qui va permettre de retrouver un col ouvert ou entre-ouverts avec un produit de conception déjà au niveau du col ou au niveau de l'isthme.

(17:52 - 19:03)

L'échographie n'est pas obligatoire pour le diagnostic positif, cependant elle est utile pour éliminer essentiellement une grossesse gemellaire avec une expulsion du premier jumeau. Le troisième tableau clinique s'agit de la grossesse arrêtée et le diagnostic est là souvent fait de façon fortuite, systématique lors d'une consultation habituelle et on découvre des signes échographiques de non-évolutivité de la grossesse ou bien une patiente qui vient parce qu'elle est inquiétée, parce qu'elle a saigné ou bien qui voit son utérus non augmenté de volume, par exemple une patiente qui considère que sa grossesse est de 3 ou 4 mois alors qu'elle touche au niveau des pelvis et ne retrouve pas l'utérus qui devrait être supubien. C'est l'échographie qui va permettre de voir le diagnostic et de le confirmer en mettant en évidence soit un embryon avec absence d'activité cardiaque comme vous le voyez sur l'image d'en bas ou bien parfois un aspect d'œuf clair ou de sac festonné hypotonique même parfois en voie d'expulsion.

(19:04 - 19:59)

Pour ceci et pour pouvoir interpréter il faut en général connaître les repères échographiques de la grossesse jeune, sachant que le sac gestationnel en général apparaît vers 5 semaines, la visicule vitéline apparaît à 5 semaines plus 4 jours et en général l'embryon va apparaître à 6 semaines et l'activité cardiaque apparaît à 6 semaines et demi voire 7 semaines. Donc l'absence de ces repères là met en doute en général l'évolutivité de la grossesse. Quatrième tableau clinique et qui est l'avortement incomplet où la patiente va venir décrivant des douleurs expulsives des météorologies abondantes avec une expulsion d'un produit puis la régression des douleurs et aussi la régression des saignements.

(20:00 - 21:06)

Donc le col en général est encore ouvert et parfois on retrouve des débris trophoblastiques au

niveau du vagin et le diagnostic va être fait à l'échographie qui va montrer comme vous le voyez sur cette image la persistance de quelques débris trophoblastiques ce qu'on appelle la rétention trophoblastique et qui va nécessiter une prise en charge adaptée. Le dernier tableau clinique qui peut être une occasion de diagnostiquer un avortement spontané est l'avortement complet où la patiente décrit le tableau de saignement associé à des douleurs puis l'expulsion d'un produit puis par la suite l'arrêt des saignements ou la diminution importante et la disparition des douleurs. Le col est en général fermé et l'échographie va permettre de voir et de confirmer une vacuité utérine comme vous le voyez sur cette image avec un endomètre très fin et absence de tout sac ou de tout produit de conception au niveau du col.

(21:08 - 24:07)

Donc face à des météorologies sur une grossesse connue ou parfois non connue, il y a plusieurs diagnostics différentiels qui doivent être éliminés et il s'agit essentiellement des causes des météorologies du premier trimestre la grossesse extra-utérine qui est une urgence médico-chirurgicale la molle hédatiforme et les causes cervico-vaginales qui s'agit de causes infectieuses de causes inflammatoires mais c'est surtout les causes tumorales qui doivent être éliminées dans tous les cas et comme on l'avait vu lors du cours sur la grossesse, le frottis cervico-vaginal doit être systématique au premier trimestre si la patiente n'a pas de frottis déjà réalisés donc une fois le diagnostic fait, on va passer à la prise en charge et cette prise en charge est dépendante du tableau clinique et varie en fonction du type d'avortement. En cas de menace d'avortement après avoir confirmé la vitalité de la grossesse à l'échographie il faut rassurer la patiente lui conseiller un repos avec une réduction des activités physiques et aussi des activités sexuelles cependant, il ne faut pas prescrire le repos strict au lit puisqu'il n'a pas été démontré qu'il améliore les chances de poursuite de la grossesse et qu'il peut avoir des effets secondaires, notamment une augmentation de risque de maladie thromboembolique les antispasmodiques sont utiles si la patiente a des douleurs et en cas d'étiologie évidente comme les causes infectieuses il faut traiter ces causes là il n'y a pas de traitement efficace pour arrêter une menace d'avortement cependant l'adidrogesterone qui est un isomère de la progesterone naturelle a été utilisé avec probablement une réduction de ce risque d'évolution vers un avortement devant un tableau d'avortement en cours, il n'y a aucune possibilité d'arrêter ce processus d'avortement et le rôle du médecin est essentiellement d'assurer l'hémostase et d'éviter une hémorragie importante donc si pas d'hémorragie ou hémorragie minime on privilégie le traitement médical par des utérotoniques pour favoriser l'expulsion du produit de conception par les prostaglandines, misoprostone ou bien le métergin tout en assurant un traitement antalgique. En cas d'hémorragie de grande abondance il faut rapidement assurer l'hémostase et le seul moyen reste le curtage hémostatique par aspiration ou par curage digital en parallèle avec les mesures de réanimation.

(24:08 - 25:44)

En cas d'avortement incomplet, c'est à dire une rétention de produit de conception ou rétention trophoblastique on a le choix entre un traitement médical à base de misoprostone avec 4

comprimés toutes les 6 heures par voie vaginale pendant 24 heures ou bien faire un curtage aspiratif d'emblée ou de deuxième intention et dans les cas où cette rétention date de plus de 1 mois il faut privilégier la résection sous contrôle visuel par l'hystéroscopie pour éviter le risque de synéchie qui est très élevé dans cette situation. En cas de grossesse arrêtée on a 3 options de prise en charge puisque la patiente en général ne saigne pas soit attendre l'expulsion spontanée avec un délai allant de 1 semaine jusqu'à 2 semaines mais en prenant en considération le retentissement psychologique sur la patiente soit donner un traitement médical par les prostaglandines qui est le traitement à privilégier soit si échec ou de première intention réaliser une dilatation du col avec un curtage aspiratif. Il existe plusieurs protocoles d'administration de misoprostone en cas de grossesse arrêtée un des plus efficaces est celui adopté par notre service et de mettre 4 comprimés de misoprostone toutes les 6 heures 3 fois les premières 24 heures et réévaluer la patiente le lendemain.

(25:44 - 26:44)

Si elle a expulsé, réaliser un col une échographie de contrôle si la patiente n'a pas expulsé on peut soit faire sortir la patiente et la revoir 7 jours après puisque dans un grand nombre de cas l'expulsion va survenir dans les 5 jours après la mise en place du misoprostone. Cependant il existe un risque hémorragique important pour les grossesses plus de 8 semaines et dans ces cas-là on privilégie de faire l'aspiration immédiatement si il n'y a pas d'expulsion après les premières 24 heures. Il ne faut pas oublier d'envoyer le produit d'expulsion à la monopathe essentiellement pour éliminer la molle partielle et les anomalies de placentation de réaliser et de vérifier est-ce que la patiente a un groupage pour réaliser une prévention de l'iso-immunisation si la patiente est résus négatif et si celle-ci est indiquée.

(26:44 - 27:51)

En général, elle est indiquée et recommandée et considérée comme obligatoire à chaque fois qu'on réalise un geste endo-utérin après une fausse couche, que ce soit après une rétention ou au cours d'un avortement en cours et donc dans les cas où on réalise une aspiration ou un curage digital il faut obligatoirement administrer l'anti-D pour la prophylaxe anti-D chez les patients résus négatifs. Selon les recommandations anglaises, chez les patients ayant des menaces d'avortement, c'est-à-dire des saignements sur une grossesse évolutive ou bien même un avortement mais sans intervention, c'est-à-dire une expulsion spontanée, l'administration de l'anti-D n'est pas obligatoire. Avant de terminer, on va parler d'un cas particulier qui est celui des patients ayant des avortements à répétition, ce qu'on appelle la maladie abortive qui est définie par la survenue de deux avortements successifs chez une patiente sans qu'elle ait de grossesse intercalaire menée à terme.

(27:52 - 29:03)

C'est un cas particulier par le retentissement psychologique sur le couple et par le problème

diagnostique étiologique et de prise en charge thérapeutique. Devant ces cas, il faut toujours rechercher des étiologies qui sont pratiquement les mêmes et il s'agit des causes génétiques, anatomiques, endocriniennes, immunologiques, hématologiques et surtout de thrombophilie et des causes parfois même masculines. Devant une patiente ou un couple qui a des avortements à répétition, il faut obligatoirement réaliser un bilan systématique qui commence par un interrogatoire pour rechercher des facteurs de risque ou des signes d'orientation envers une pathologie existante, notamment de diabète, d'hyperprolactinémie, de maladie de système d'anomalies congénitales, utérines ou autres, donc un interrogatoire bien détaillé, un examen clinique et il faut obligatoirement réaliser une échographie pelvienne afin d'éliminer des anomalies anatomiques de l'utérus, notamment des utérus cloisonnés ou des fibromes.

(29:04 - 29:51)

Réaliser un bilan thyroïdien systématique, même en l'absence de signes cliniques évocateurs et il faudra réaliser la TSH et les anticorps anti-TPO. La recherche d'anticorps antiphospholipides doit être aussi systématique, même en l'absence de signes cliniques, cependant d'autres bilans comme le dosage de la prolactine est uniquement indiqué s'il y a des signes d'orientation, notamment de Spanio-Menoré ou de Galactoré. La prise en charge des avortements spontanés à répétition est compliquée et nécessite un bilan comme on vient de le dire et dans les cas où on retrouve une étiologie il faudra mettre en oeuvre un traitement spécifique.

(29:52 - 30:26)

En cas de cerclage, il faudra pardon, en cas de baillance cervicale, il faudra réaliser un cerclage utérin entre 12 et 14 semaines. En cas de malformation utérine notamment de cloison utérine, il faudra réaliser une cure de cette malformation par hystéroscopie opératoire. En cas de syndrome d'anticorps antiphospholipide, il faudra mettre en oeuvre un traitement spécifique, le plus souvent par héparine de bas poids moléculaire et d'aspirine à faible dose, à dose antiagrégante plaquettère.

(30:28 - 31:18)

Dans les cas de pathologie immunologique ou parfois même d'avortement idiopathique, une corticothérapie peut parfois être discutée. Chez les couples ayant des anomalies chromosomiques parentales notamment des translocations, un diagnostic préimplantatoire peut être discuté. Dans pratiquement 30% des cas, il n'y aura pas de cause retrouvée et c'est le cas le plus difficile à traiter et on peut discuter la mise en oeuvre d'un traitement par des corticoïdes, d'aspirine, même d'HBPM et plus récemment d'hydrogestérone a montré un bénéfice pour la réduction de risque de récurrence de ces avortements à répétition.

(31:20 - 32:12)

Un cas particulier de la baillance cervicale qui représente pratiquement 20% des avortements de

deuxième trimestre et où le diagnostic est souvent fait uniquement à l'interrogatoire puisque la patiente vient en cours de grossesse et on ne peut pas à ce moment-là faire ni d'hystérosalpingographie ni d'introduction de la bougie au niveau du col. Dans ces cas-là, c'est l'interrogatoire qui va permettre de poser le diagnostic en retrouvant des antécédents parfois d'accouchement prématuré puis d'avortement tardif avec un rajeunissement de plus en plus important de l'âge de la grossesse au moment de l'avortement. La description de la patiente d'un avortement sans grande douleur est d'un nouveau-né en général ou plutôt d'un fœtus vivant.

(32:13 - 33:13)

Ceci est suffisant pour indiquer un traitement spécifique par encerclage qu'on réalise en général entre 12 et 14 semaines et qui est souvent efficace pour maintenir la grossesse jusqu'au terme. En conclusion, les avortements spontanés sont une pathologie fréquente avec parfois un risque vital dans l'immédiat dans les formes hémorragiques, d'où la nécessité d'un diagnostic très précoce et une prise en charge rapide et adaptée. Il existe un retentissement psychologique parfois important, surtout chez les patientes ayant des avortements à répétition, d'où l'intérêt d'informer les patientes et d'assurer un soutien psychologique pour ces patientes-là après, bien sûr, avoir réalisé un bilan étiologique et, si une cause est identifiée, mettre en œuvre un traitement.

(33:14 - 33:15)

Je vous remercie.